Bolam 测试

英国侵权法学习指南 | 专业技能、治疗与知情同意

一、采用专业比较基准

被告运用或声称具备某种特殊技能时，通常应与运用该技能的合理胜任专业人员比较。医疗决策不能仅按没有医学训练的普通公众会怎样做来评价。法律不要求最高水平的专家能力，但要求达到适当的专业胜任标准。

专业技能必须与争议活动有关。历史学家的专业知识，不会自动提高其在普通驾驶事故中的注意标准。应确定具体任务和相关专业，而不是让有资格证书的人在一切行为中都承担特殊责任。

二、Bolam 原则

Bolam v Friern Hospital Management Committee [1957] 1 WLR 582 说明：若行为符合相关专业中一个负责任的专业意见群体认可的适当做法，就不能仅因另一个群体会采取不同做法而认定过失。

支持该做法的群体不必占人数多数。但找到一个愿意支持被告的人，不等于自动免责。专业意见必须负责任并可由逻辑支持；Bolitho 对此作了澄清。

三、仍然是客观评价

选择专业基准，并不意味着采用被告个人能力作为标准。“这个医生是否尽了自己的最大努力？”或“他是否真心认为这样正确？”都不是决定性问题。法院应按适用的专业标准评价实际行为。

> 相关技能 → 合理胜任的专业人员 → 负责任的专业做法 → 逻辑审查。事实帮助确定适用基准，并不使测试变成纯主观测试。

名称应为 Bolam 和 Friern。专业标准不是对每种活动统一加码，而是针对正在运用的具体专业能力。

Bolam：最初的案件

一、事实：电休克治疗

Bolam 先生接受了电休克治疗（ECT），即通过电流诱发癫痫样发作的医疗治疗。他在治疗中发生严重骨折。过失指控涉及未使用肌肉松弛药物、身体约束的程度，以及未告知骨折风险。

医学专家对当时合适的做法存在分歧，包括肌松药和约束措施的风险与益处。因此，该案不只是未提供信息的问题，也涉及治疗如何实施。

二、谁胜诉？为什么？

被告医院管理委员会胜诉。McNair 法官向陪审团解释了专业标准及负责任医学意见的重要性；陪审团随后作出有利于被告的裁决。伤害本身不能证明治疗存在过失。

两个负责任的专业流派意见不同，并不自动说明其中一个有过失。另一方面，专业身份也不能保护不谨慎行为；实际操作仍须达到要求。

三、今天如何使用该案

Bolam 对临床诊断和治疗仍有重要意义，并受 Bolitho 的司法审查限制。但不能把该案历史上的风险告知方式，当作当今知情同意的一般规则。Montgomery 要求另行分析重要风险与合理替代方案。

虚构例子：两种技术各有负责任、逻辑上可辩护的专业意见支持。选择其中一种，不会仅因另一位专家更喜欢另一种就构成 breach。但未能熟练实施所选技术，是另一个问题。

> 分开问：临床方案在专业上是否可辩护？实施过程是否胜任？患者是否获得充分信息？一个问题的答案不会自动决定另外两个。

例子为虚构。Bolam 涉及20世纪50年代的医疗实践，属于法律史材料，不是当代 ECT 临床操作指南。不要把历史裁决当作现行医疗指导。

Bolitho：必须有逻辑基础

一、法院仍保留审查作用

在 Bolitho v City and Hackney Health Authority [1998] AC 232 中，上议院澄清：即使专家真诚支持某种做法，也不自动决定案件。专业意见必须有逻辑基础，包括对相关风险与益处作出可辩护的权衡。

这不意味着法官可以用个人喜好取代医学专业判断。如果两个观点在逻辑上都可成立，法官仅偏好其中一个，不足以否定另一个。法院强调，否定胜任专家的专业意见属于例外。

二、事实与结果

一名幼童发生灾难性呼吸衰竭。医生被呼叫后未到场，这一过失已获承认。还需问：若医生到场，是否会插管？不插管本身是否构成过失？

卫生机构在上议院胜诉。支持不插管的专业意见未被证明不合逻辑。原告未能证明未到场造成损害：若医生作出可辩护的不插管决定，仍不会阻止随后的呼吸崩溃。

三、对学习的意义

该案联系了 breach 与因果关系，但没有把两者合并。证明一次过失不作为，并不等于证明它造成伤害。反过来，被告也不能仅说“我本来还会实施另一项过失行为”，就否定因果关系。

虚构例子：专家支持省略简单防护措施，却无法合理解释为何忽视已知严重风险。法院可以审查意见是否真正负责任。“另一个专业人员同意我”不是完整的法律测试。

> Bolam 重视负责任的专业做法；Bolitho 要求其经得起逻辑分析。得到专家支持，不等于必然抗辩成功。

Bolitho 判于1997年，收录于 [1998] AC 232，是对转录的补充澄清。防护措施例子为虚构，并非该案额外认定的事实。

Montgomery：患者的选择

一、另一类问题：知情选择

Montgomery v Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11 涉及一名患糖尿病的孕妇。医生未告知阴道分娩中肩难产的风险，即婴儿肩部被卡住。该并发症发生，孩子受到严重伤害。

Montgomery 女士在最高法院胜诉。医生应讨论重要风险及剖宫产选项。法院还认定，若获得适当告知，她会选择剖宫产，从而避免该伤害。

二、什么是重要风险（material risk）？

医生须采取合理谨慎，使患者了解建议治疗的重要风险与合理替代方案。若处于患者位置的合理人可能重视该风险，或者医生知道或合理应当知道这名具体患者可能重视它，该风险就具有重要性。

这不只是问其他医生通常会告知什么。法律保护患者的决定。测试既关注合理患者，也关注具体患者；不由医生的主观偏好决定。应有患者能够理解的交流，而不只是签署表格。

三、后续澄清：McCulloch

在 McCulloch v Forth Valley Health Board [2023] UKSC 26 中，家属主张医生应讨论某种药物选择。卫生机构胜诉。哪些替代方案在临床上合理，采用受 Bolitho 限制的专业实践测试。Montgomery 规范对重要风险与合理选项的讨论，而非要求提供一切想象得到的疗法。

> 临床诊断 / 治疗：Bolam 加 Bolitho 审查。重要风险告知：Montgomery。替代方案的临床合理性：McCulloch 澄清的专业判断。

名称是 Lanarkshire，不是 Lancashire。最高法院两案源于苏格兰，但澄清了英格兰和威尔士使用的原则。告知会严重损害健康或紧急必要情况下的狭窄例外，不允许仅为防止患者拒绝治疗而隐瞒风险。

理解与自测

1. 为什么不把医生与未受训练的普通人比较？
答案： 任务需要专业技能。适当基准是运用相关技能的合理胜任专业人员。

2. 选择专业基准使测试变成主观测试吗？
答案： 不会。事实确定基准；个人信念或“已尽最大努力”不能取代客观标准。

3. Bolam 中谁胜诉？
答案： 医院管理委员会。陪审团听取专业标准的法律指示后判被告胜诉；受伤本身不能证明过失。

4. 有一位专家支持就一定能抗辩成功吗？
答案： 不能。实际行为必须符合负责任、经得起逻辑分析的专业做法。

5. Bolitho 补充了什么？谁胜诉？
答案： 法院可审查专业意见的逻辑基础。卫生机构胜诉，因为不插管意见可辩护，且未证明因果关系。

6. Montgomery 如何判断风险的重要性？
答案： 合理患者可能重视它，或者医生应知道这名具体患者可能重视它。满足任一路径即可。

7. Montgomery 废除了所有医疗问题中的 Bolam 吗？
答案： 没有。它改变了风险告知的方法。临床判断仍须区分；McCulloch 涉及合理替代方案。

> 答题顺序：确定任务 → 区分临床判断与风险告知 → 选择测试 → 分析证据与理由 → 判断 breach → 检查因果关系与可诉损害。

资料来源

根据所提供 Law Academy 转录整理，修正名称和法律区分。补充 Bolitho 与 McCulloch。判决原文：Bolam [1957] 1 WLR 582, 586-588; Bolitho [1998] AC 232. Montgomery [2015] UKSC 11, paras 87-90 and 103-105; McCulloch [2023] UKSC 26. 虚构例子已标明。